

extensivo

ENARE

by Residência PRO

ENFERMAGEM • MÓDULO 1

BLOCO 03 • AULA 01

O ENARE E A ENFERMAGEM

**O QUE A FGV
REALMENTE COBRA**

01

O QUE VOCÊ VAI APRENDER

- 01** Entender a lógica da banca FGV para enfermagem — o que ela cobra e como constrói as questões
- 02** Distinguir o que é cobrança de residência multiprofissional do que é cobrança de concurso público
- 03** Mapear os temas de maior incidência no ENARE de Enfermagem e planejar seu estudo com estratégia

PRÉ-REQUISITO

Bloco 00 — SUS Tronco Comum. Esta aula assume familiaridade com a estrutura do SUS, RAS e Atenção Primária à Saúde. Se ainda não assistiu o Bloco 00, faça antes de avançar neste bloco — o Módulo 1 usa o SUS como pano de fundo constante.

□ DICA DE PROVA

Esta aula não tem conteúdo clínico para memorizar — é uma aula de calibragem. Mas não pule: quem entende o raciocínio da FGV erra menos nas próximas 22 aulas.

Duração estimada da aula em vídeo: 40 min · [Questões de fixação neste PDF: 3](#) · Aula: 1 de 23 do Bloco

PERFIL DA BANCA FGV NO ENARE

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca responsável pelo ENARE (Exame Nacional de Residência) desde 2021. Entender como ela formula questões é tão importante quanto dominar o conteúdo — candidatos que estudam conteúdo sem entender o estilo da banca costumam errar questões que sabem responder.

□ CONCEITO-CHAVE

A FGV **não testa memorização pura**. Ela apresenta cenários clínicos contextualizados no SUS e exige que o candidato tome decisões como profissional inserido na rede — não como estudante decorando protocolos isolados.

O que a FGV realmente avalia

- **Raciocínio clínico contextualizado no SUS:** o enunciado traz um caso em UBS, CAPS, UPA ou hospital de referência — o candidato precisa agir como enfermeiro do SUS naquele contexto
- **Tomada de decisão por exclusão:** geralmente 2 alternativas estão claramente erradas, 2 são plausíveis e 1 é a mais correta dentro da lógica do SUS
- **Integração entre áreas:** uma questão de saúde da mulher pode exigir conhecimento de SAE; uma questão de urgência pode exigir conhecimento de segurança do paciente
- **Legislação como contexto, não como decoreba:** resoluções do COFEN, leis federais e portarias do MS aparecem como fundamentação de condutas — não como questões de "qual o número desta lei"

O que a FGV NÃO faz

- Não pergunta números de resoluções sem contexto clínico
- Não cobra procedimentos técnicos isolados (ex: sequência de passos de um curativo)
- Não cria enunciados com cenários hospitalares de alta complexidade terciária desconectados do SUS
- Não usa "pegadinhas" de vocabulário — as alternativas erradas são plausíveis clinicamente

RESIDÊNCIA × CONCURSO PÚBLICO

A maioria dos candidatos ao ENARE estudou para concursos públicos de prefeitura ou estado antes. Esse histórico pode atrapalhar: a lógica de estudo é diferente.

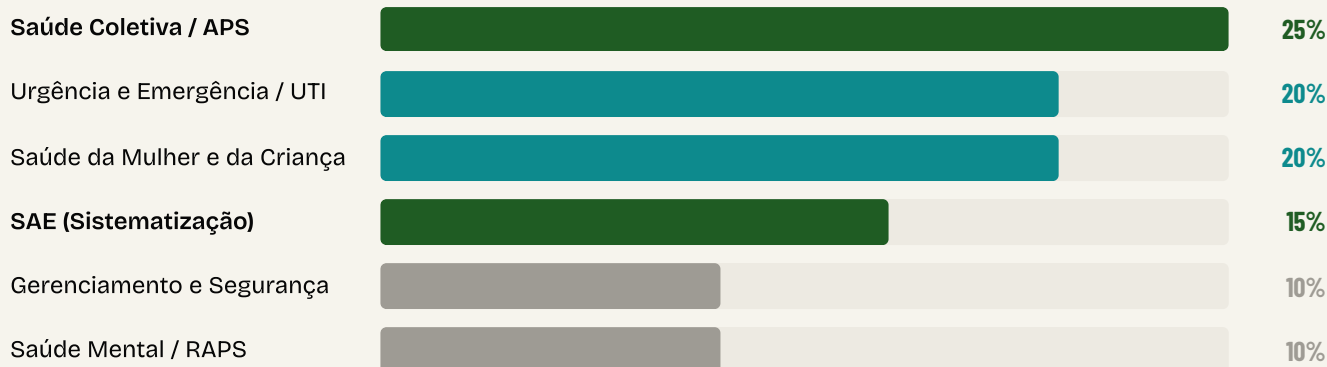
DIMENSÃO	ENARE (FGV)	CONCURSO PÚBLICO TÍPICO
Cenário das questões	Sempre contextualizado no SUS (UBS, CAPS, UPA, hospital SUS)	Frequentemente sem contexto ou em cenários genéricos
O que é cobrado	Raciocínio clínico + tomada de decisão	Memorização de protocolos, legislação e procedimentos
SAE / NANDA	Aplicada em casos clínicos — pede o diagnóstico ou a intervenção correta para o caso	Pede definição de etapas, taxonomia, conceitos isolados
Legislação	Aparece como base para conduta clínica — "com base na Lei X, o enfermeiro deve..."	Pergunta diretamente o número, ano e artigos da lei
Nível das alternativas	Alternativas clinicamente plausíveis — exige discriminação fina	Alternativas muitas vezes com erros claros — eliminação fácil
SUS como pano de fundo	O SUS é o cenário de toda questão — política, rede, fluxo	SUS pode aparecer de forma superficial e desconexa

⚠ PEGA NO ENARE

Candidatos que vêm de concursos públicos costumam **decorar em vez de raciocinar**. A FGV detecta isso: ela constrói distratores clinicamente plausíveis para quem memorizou sem entender o contexto do SUS. O antídoto é estudar sempre perguntando *"por que essa conduta faz sentido nessa rede?"*

DISTRIBUIÇÃO DE TEMAS NO ENARE (ENFERMAGEM)

Com base nas questões do ENARE 2025 (FGV/EBSERH), a distribuição estimada para Enfermagem é:



⚠ PEGA NO ENARE

Saúde Coletiva/APS + SAE = 40% das questões. Quem negligencia APS porque "não trabalha em UBS" está abandonando quase metade da prova. A FGV cobra enfermeiro do SUS — e o SUS é, majoritariamente, atenção primária.

Implicação estratégica para o estudo

- **Alta prioridade (>20%):** APS/Saúde Coletiva, Urgência/UTI, Saúde da Mulher e Criança — domine esses 3 blocos e já tem 65% cobertura
- **Média prioridade (15%):** SAE — tema transversal que aparece dentro de questões de outras áreas; domine bem antes de avançar
- **Não negligenciar (10% cada):** Gerenciamento/Segurança e Saúde Mental — juntos valem 20% e tendem a ter questões com menor concorrência entre candidatos

COMO USAR ESTE BLOCO

O Bloco de Enfermagem foi estruturado em 10 módulos progressivos. A sequência abaixo é a recomendada — alterar a ordem pode comprometer a construção do raciocínio clínico.



Integração obrigatória com o Bloco 00 (SUS)

Cada módulo deste bloco assume o SUS como pano de fundo. Se você ainda não completou o Bloco 00, faça antes:

- **APS e ESF (Bloco 00)** → usados em todo o Módulo 3 (Saúde da Mulher) e Módulo 4 (Saúde da Criança)
- **Redes de Atenção (RAS) (Bloco 00)** → base para localizar o enfermeiro no sistema em questões de competência
- **Políticas de Saúde (Bloco 00)** → contexto das portarias que aparecem em questões de PNAO, RAPS e PNSP

📌 DICA DE PROVA

Antes de responder qualquer questão deste bloco, pergunte: **"Em qual ponto da RAS está esse paciente?"** Essa pergunta recalibra automaticamente o raciocínio para a lógica do SUS que a FGV espera.

QUESTÕES COMENTADAS

QUESTÃO 01 DE 03 · PERFIL DA BANCA FGV

Uma enfermeira recém-aprovada no ENARE relata que se surpreendeu com a prova: "Esperava questões sobre técnicas de enfermagem e nomenclaturas NANDA, mas as questões me pediam para tomar decisões como se eu já estivesse trabalhando na UBS." Essa percepção reflete uma característica central da banca FGV no ENARE, que prioriza a avaliação de:

- A Memorização de taxonomias de enfermagem e seus respectivos códigos alfanuméricos padronizados pela NANDA-I Internacional
- B Conhecimento técnico de procedimentos hospitalares de alta complexidade, com foco em cuidados intensivos terciários
- C **Raciocínio clínico contextualizado na Rede de Atenção à Saúde do SUS, com tomada de decisão em cenários reais do serviço público** **GABARITO**
- D Capacidade de enumerar legislações profissionais pelo número, ano de publicação e artigos específicos do COFEN e do Ministério da Saúde
- E Domínio de farmacologia avançada e interações medicamentosas aplicadas ao contexto da terapia intensiva adulta e pediátrica

GABARITO COMENTADO

C – CORRETA.

A FGV estrutura as questões do ENARE como cenários clínicos dentro do SUS (UBS, CAPS, UPA, hospital de referência). O candidato é colocado no papel de enfermeiro que precisa decidir – não de estudante que precisa definir.

A – Incorreta.

Taxonomias NANDA aparecem aplicadas em casos clínicos, não como conteúdo isolado de memorização de códigos ou definições.

B – Incorreta.

Embora urgência e UTI estejam no bloco, o foco sempre é o enfermeiro do SUS – não procedimentos de alta complexidade desconectados da rede.

D – Incorreta.

Legislação aparece como fundamentação de condutas, não como decoreba de números e artigos. A FGV usa a lei para justificar a alternativa correta, não para testá-la isoladamente.

E – Incorreta.

Farmacologia não é o foco central do ENARE de Enfermagem. Quando aparece, é no contexto de condutas do enfermeiro (ex: administração segura, bundles de UTI).

QUESTÃO 02 DE 03 · DISTRIBUIÇÃO DE TEMAS

Um candidato ao ENARE pretende otimizar seu tempo de estudo para o bloco de Enfermagem e pergunta a um colega veterano quais são as áreas de maior incidência na prova. Com base na distribuição histórica das questões do ENARE (FGV/EBSERH), a área com maior percentual de cobrança para enfermagem é:

- A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), com aproximadamente 25% das questões do bloco
- B Urgência e Emergência/UTI, com aproximadamente 25% das questões do bloco
- C Saúde da Mulher e da Criança, com aproximadamente 25% das questões do bloco
- D Saúde Coletiva e Atenção Primária à Saúde (APS), com aproximadamente 25% das questões do bloco** **GABARITO**
- E Gerenciamento e Segurança do Paciente, com aproximadamente 25% das questões do bloco

GABARITO COMENTADO

D – CORRETA.

Saúde Coletiva e APS lideram com ~25% das questões de Enfermagem. Isso reflete o perfil do ENARE: uma prova de residência multiprofissional em saúde, cujo cenário central é o SUS e sua porta de entrada – a Atenção Primária.

A – Incorreta.

SAE representa ~15% das questões. É alta incidência, mas fica atrás da APS. Além disso, SAE aparece frequentemente integrada a questões de outras áreas, não isolada.

B – Incorreta.

Urgência/UTI representa ~20% – segunda área, empatada com Saúde da Mulher e Criança. Maior que SAE, mas menor que APS.

C – Incorreta.

Saúde da Mulher e Criança representa ~20% – empata com Urgência/UTI. Importante, mas não lidera o ranking.

E – Incorreta.

Gerenciamento e Segurança representam ~10%. Menor incidência, mas com questões frequentemente mais difíceis – candidatos que negligenciam essa área tendem a perder pontos que os outros acertam.

QUESTÃO 03 DE 03 · QUESTÃO-ÂNCORA · PAPEL DO ENFERMEIRO NA APS

Em uma Unidade Básica de Saúde do interior de Minas Gerais, uma enfermeira realiza consultas de enfermagem de forma autônoma, sem necessidade de encaminhamento médico prévio, identificando problemas de saúde e prescrevendo cuidados dentro de seu campo de atuação. Um técnico de enfermagem questiona a legalidade dessa prática, afirmando que "consulta é coisa de médico." A conduta da enfermeira está fundamentada em:

- A Portaria do Ministério da Saúde que autoriza o enfermeiro a realizar consultas apenas em municípios sem médico disponível na equipe de ESF
- B Decisão discricionária do gestor municipal de saúde, que pode autorizar ou proibir a consulta de enfermagem conforme a necessidade local
- C Lei 7.498/1986 e Resolução COFEN 159/1993, que estabelecem a consulta de enfermagem como atividade privativa do enfermeiro, independente de autorização médica** **GABARITO**
- D Acordo informal entre a equipe de saúde da UBS, que delega atribuições conforme a disponibilidade de profissionais em cada turno de atendimento
- E Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que, em caráter excepcional, permite ao enfermeiro realizar atos de diagnóstico em regiões remotas

GABARITO COMENTADO

C – CORRETA.

A Lei 7.498/1986 (exercício da enfermagem) e a Resolução COFEN 159/1993 garantem ao enfermeiro a prerrogativa de realizar consulta de enfermagem como ato privativo, com autonomia técnica e científica. Não depende de autorização médica nem de decisão do gestor. Esta é uma distinção fundamental que a FGV explora: a consulta de enfermagem não é delegação – é competência legal própria.

A – Incorreta.

Não existe limitação geográfica para a consulta de enfermagem. A lei não condiciona a prática à ausência de médico na equipe.

B – Incorreta.

A consulta de enfermagem é direito legal do profissional – o gestor não tem poder de proibi-la, muito menos de condicioná-la a critérios locais.

D – Incorreta.

Acordos informais não têm validade jurídica para fundamentar atos privativos. A prática está amparada em lei federal – acima de qualquer acordo de equipe.

E – Incorreta.

O CFM regula a medicina, não a enfermagem. A competência do enfermeiro é regulada pelo COFEN. Nenhuma resolução do CFM pode ampliar ou restringir os atos privativos de outra categoria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 1986.

BRASIL. **Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987.** Regulamenta a Lei nº 7.498/1986 sobre o exercício da enfermagem. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jun. 1987.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 159, de 19 de abril de 1993**. Dispõe sobre a consulta de enfermagem. Rio de Janeiro: COFEN, 1993.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009.** Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Rio de Janeiro: COFEN, 2009.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV). **ENARE 2025 — Exame Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde**. Rio de Janeiro: EBSERH/FGV, 2025. [Prova e gabarito oficial].

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)**. Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

MINHAS ANOTAÇÕES